

Hiponatremia · conduta e correção

Na hiponatremia, determine tonicidade (hipo/iso/hipertônica), volemia e sintomatologia. Sintomas graves pedem salina hipertônica; crônica assintomática pede correção lenta.

Volemia guia a causa

Dica - Volemia guia a causa

Hipovolêmica: perdas + reposição hipotônica. Euvolêmica: SIADH, hipotireoidismo, glicocorticoides.

Hipervolêmica: IC, cirrose, DRC — retenção de água livre.

Confirme hiponatremia hipotônica verdadeira; depois classifique volemia (hipo/eu/hipervolêmica).

Osmolaridade serica

Primeiro passo antes de dar soro

$$\text{Osm} = 2 \cdot \text{Na} + \text{glicose}/18 + \text{ureia}/6$$

Hipotonica: Osm baixa. Hiperglicemia e pseudo (hiperlipidemia) confundem.

Conduta por gravidade

- Sintomas graves (convulsão, coma): bolus de NaCl 3% e reavaliar neurologicamente
- Moderada sintomática: correção controlada + tratar causa
- Crônica oligossintomática: restrição hídrica (SIADH), salina isotônica se hipovolêmica
- Meta usual de correção: evitar >8–10 mEq/L em 24 h (mais restrito se alto risco de ODS)

Causas frequentes em prova

Perfil | Exemplos

Hipovolêmica | Diuréticos, vômitos, perdas GI

Euvolêmica | SIADH (pulmonar/SNC/fármacos)

Hipervolêmica | IC, cirrose, síndrome nefrótica

Hipertônica | Hiperglicemia grave

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Correção excessivamente rápida da hiponatremia crônica pode causar mielinólise osmótica (ODS). Sintoma grave justifica hipertônica, mas não 'normalize o Na em horas'.